

SOAL 2



RESUME RAWAT INAP

Nama Pasien	: XXX	Tgl. Masuk	: 17/01/2025
No. RM	: XXX	Tgl. Keluar	: 03/02/2025
Tgl. Lahir	: XXX	Lama Dirawat	: 16 Hari
No JKN	: XXX	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
No SEP	: XXX	Alergi Obat	Tidak Ada

Keluhan Utama	BAK berdarah
Perkembangan Selama Perawatan	BAK kemerahan disertai gumpalan darah sejak beberapa hari yang lalu. nyeri perut bawah +, badan lemas, mual dan muntah. intake oral terganggu, meriang +. saat rawat inap, pasien demam, batuk dan sesak, os dirawat dengan medikasi dan pemantauan ketat, pemeriksaan kultur aerob (+) kuman, di tengah rawatan pasien sempat demam 41 derajat Celcius, hasil kultur darah (+) E.Coli, sesuai arahan DPJP os diberikan terapi antibiotik lini 3, kondisi sempat perbaikan namun kembali os perburukan, desaturasi SpO2 hingga 71%, penurunan kesadaran dan dilakukan intubasi ventilator, kondisi perburukan pasien dinyatakan meninggal dihadapan keluarga, os dipulasarakan di kamar jenazah.
Pemeriksaan Fisik	- K: CM, KU: Sedang. agak pucat. - KU: Berat, kesadaran E2M3VET pemasangan NGT - TD: 184/95, HR: 127, Suhu: 41 C, SPO2: 71% on VSIMV 100%. - Kepala: konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik. pulmo: suara napas vesikuler, rhonki +/- wheezing -/-. cor: bunyi jantung 1-2 reguler, tidak ada murmur dan gallop. - abdomen: bising usus normal, supel, nyeri tekan tidak ada. - ekstremitas: akral hangat, CRT <2 detik, edema pretibial +/-. - status uro: CVA D.S : NK +/- minimal. - SS: NT+ 02/02/2025 Pukul 16.30 Monitor bradikardi - S : kontak - - O : KU berat, kesadaran E1M1Vett nadi karotis tidak teraba nafas spontan tidak ada, TD tidak terukur, saturasi tidak terbaca - A : Cardiopulmonary Arrest, Gagal nafas ec pneumonia dd/ metastasis paru, Syok Sepsis, pneumonia - P : Resusitasi -
Pemeriksaan Penunjang	USG kedua ginjal: HN bilateral gr 1-2. HU +Kista ginjal kanan tipe simple. Buli: penuh dengan blood clot, prostat sulit dinilai. PSA Des 23: 156,4 PSA juli 24: 0,76

	PSA Okt 24: 5,63 PSA Januari 25: 76,76 DPL 8,5/22,9/8780/245000 -- 7,4/22,2/7340/222000 -- 9,2/24,8/10210/185000 -- 9,9/27/10210/157000 ur/cr 126/11,06 eGFR 4,2 -- 63/6,12 eGFR 8,5 -- 47/5,65 eGFR 9,4 Na/K 111/3,7 -- 124/3,5 -- 131/3.5 Radiologi: Thorax (+) Temuan Radiologis: • Terlihat infiltrat opak pada lapang paru kanan bawah dengan distribusi non-homogen. • Pola infiltrat konsisten dengan gambaran proses inflamasi paru. • Tidak tampak kavitasi, efusi pleura signifikan, ataupun pneumotoraks. • Siluet jantung dalam batas normal. • Diafragma dan dinding toraks tampak baik. Hasil laboratorium : elektrolit (+) / hematologi lengkap (+) / Fungsi hati (+) Fungsi ginjal (+)/ Analisa Gas Darah (+) / Kultur darah (+) : ditemukan kuman Escherichia coli Kultur sputum (+) : ditemukan kuman Acinetobacter baumannii Hasil PA (+) Spesimen: Jaringan prostat hasil TURP Diagnosis: Adenokarsinoma prostat (tipe acinar), Gleason score: 3 + 4 = 7 (Grade Group 2) Derajat diferensiasi: Moderately differentiated Persentase keterlibatan tumor: ±40% dari jaringan yang diperiksa Invasi perineural: Teridentifikasi Invasi kapsular: Tidak dapat dinilai secara pasti pada spesimen TURP Jaringan jinak yang menyertai: Nodular hyperplasia (BPH) Nekrosis: Tidak ditemukan Hemorrhage / inflamasi: Tampak ringan Kesimpulan: Jaringan prostat hasil TURP menunjukkan adenokarsinoma prostat tipe acinar, Gleason score 3+4=7 (Grade Group 2), dengan invasi perineural positif. Gambaran ini sesuai dengan karsinoma prostat derajat menengah.
Diagnosis Utama	Adenocarcinoma Prostat
Diagnosis Sekunder	Gagal nafas akut Pneumonia Sepsis karena Bakteri Escherichia coli Chronic Kidney Disease Stage V karena Hipertensi tidak terkontrol Anemia Keganasan

Tindakan Utama	TURP (Trans Uretral Reseksi Prostat)
Tindakan Lainnya	Hemodialisa Transfusi Packet Red Cells USG Ginjal Intubasi Endotracheal tube (ETT) Pemasangan Ventilator <96 Jam EKG (Elektrokardiogram) Laboratorium darah Kultur darah Kultur sputum X-ray Thorax Injeksi antibiotik Patologi Anatomi Jaringan Prostat
Obat yang diberikan selama perawatan	Tracatate tablet 160 mg (megestrol), Prorenal kaplet, Nocid kaplet, B-Fluid infus, 500 ML, Co- Amoxiclav Injeksi 1,2 gram/vial-INTR telah diberikan selama 7 hari
Kondisi Saat Keluar Rumah Sakit	Meninggal
Instruksi / Tindak Lanjut	-
Cara Keluar Rumah Sakit	Meninggal > 48 jam
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)	(TTE) dr. x. Sp.U, FICS